

Colecistite aguda · diagnóstico e cirurgia

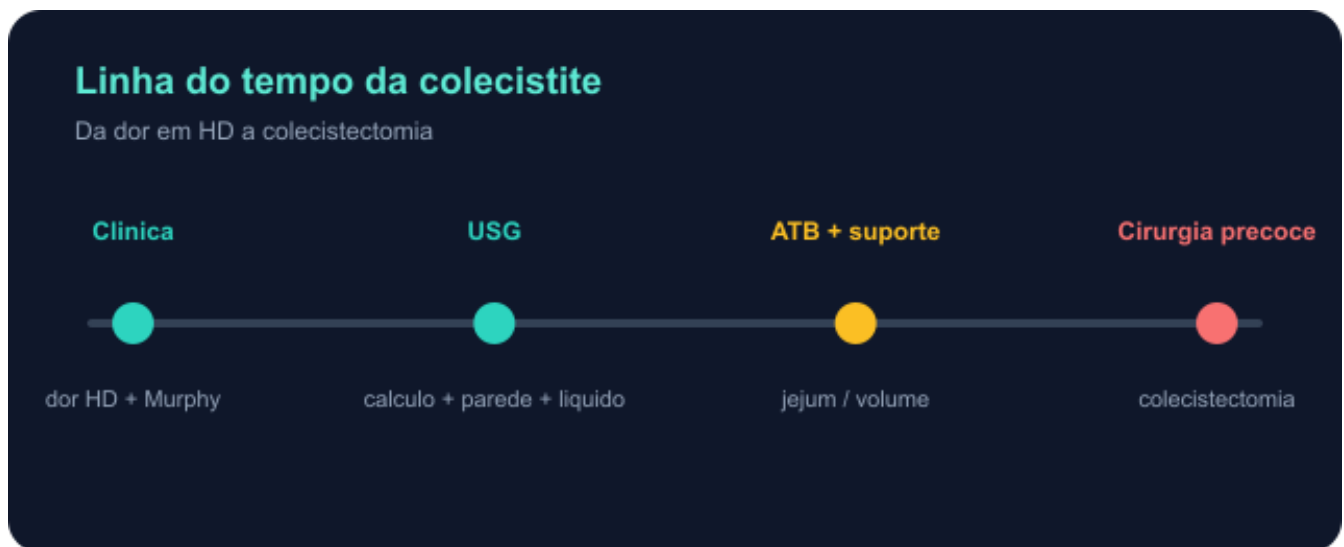
Colecistite aguda litiásica = inflamação da vesícula por obstrução do cístico. Clínica + USG + inflamação sistêmica fecham o diagnóstico; a colecistectomia precoce é o padrão no candidato cirúrgico.

Tokyo — diagnóstico

Lembre - Tokyo — diagnóstico

Sinais locais (Murphy, massa/dor em HD) + sistêmicos (febre, PCR/leucócitos) + imagem (espessamento, líquido pericolecístico, cálculo/impacto). Colangite e coledocolitíase pedem abordagem diferente.

Timeline de prova: suspeita clínica !' USG !' ATB + suporte !' cirurgia precoce (idealmente <72 h).



Conduta

- Jejum, analgesia, volume e antibiótico cobrindo enterobactérias ± anaeróbios
- Colecistectomia laparoscópica precoce na maioria dos casos operáveis
- Alto risco cirúrgico / complicação: drenagem percutânea (colecistostomia) como ponte
- Suspeita de coledocolitíase: lab colestático + imagem; CPRE conforme critério

Diagnóstico diferencial

Condição | Pista

Cólica biliar | Dor autolimitada, sem inflamação sistêmica

Colangite | Charcot/Reynolds — icterícia + infecção via biliar

Hepatite / abscesso | Enzimas / imagem hepática

Úlcera perforada | Peritonite + ar livre

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Colecistite alitiásica (UTI, jejum prolongado, vasculopatia) tem alta morbidade — não exclua só porque o USG 'não mostrou cálculo'. Imagem seriada e limiar baixo para drenagem/cirurgia.

Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

Colecistite vs colangite: Charcot e Reynolds são diferenciais clássicos. Tokyo guia diagnóstico/gravidade da colecistite aguda.

Charcot = infecção da via biliar com obstrução. Pense CPRE + ATB + suporte.

Triade de Charcot

Colangite - classico

- 1 Febre / calafrios
- 2 Icterícia
- 3 Dor em hipocondrio direito

Febre + icterícia + dor em HCD

Reynolds = Charcot + disfunção de órgãos: emergência biliar com risco de óbito.

Pentade de Reynolds

Colangite grave / choque

- 1 Febre
- 2 Icterícia
- 3 Dor em HCD
- 4 Hipotensão / choque
- 5 Alteração do nível mental

Charcot + hipotensão + alteração mental

Colecistite vs colangite

| Colecistite | Colangite

Quadro | Dor HCD, Murphy+, febre | Charcot / Reynolds

Lab | Leucocitose; bilirrubina ± | Colestase mais marcada

Imagem | USG: parede, líquido, cálculo | Dilatação VBP ± cálculo

Conduta-chave | ATB + colecistectomia | ATB + descompressão (CPRE)

Tokyo (colecistite) — ideia útil

- A: sinais locais (Murphy, massa/ dor HCD)
- B: sistêmicos (febre, PCR/leucocitose)
- C: imagem compatível
- Diagnóstico suspeito: A+B; definitivo: (A+B)+C ou achado típico forte
- Gravidade I–III guia timing operatório e necessidade de drenagem/UTI

Conduta colecistite

Lembre - Conduta colecistite

Jejum, volume, ATB, analgesia. Colecistectomia precoce (idealmente na internação índice) se apto.

Grave/instável: suporte ± drenagem percutânea e cirurgia diferida.

Não confunda

Atencao - Não confunda

Murphy+ sem icterícia/obstrução != colecistite. Charcot/Reynolds != colangite até prova em contrário — priorize via biliar.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1